

CAT EXANTHEME FEBRILE

DR:BENSOUICI.N

HMRUC

INTRODUCTION:

- **Exanthème fébrile : éruption cutanée diffuse + fièvre**

- Est un motif **fréquent** de consultations.
- L'orientation diagnostic est basée sur:
 - Analyse sémiologique des **lésions élémentaires+++**
macule ,papule, vésicule, pustule...
 - Contexte épidémiologique+++
Age, contagiosité, collectivité...

On distingue :

- Exanthèmes d'origine **infectieuse**
- Exanthèmes d'origine **non infectieuse** :toxique ou médicamenteuse

INTRODUCTION:

- Les exanthèmes fébriles infectieux: étiologies **nombreuses** et **variées**
-

➤ Etiologie **souvent virale+++**

Mais !

➤ Etiologie **bactérienne** doit être envisagée **engageant le pronostic vital**



**Des critères de gravité doivent être systématiquement
recherchés+++**

LE DÉFI POUR LE PRATICIEN EST DONC:

parmi les patients se présentant avec un tel tableau,
d'identifier ceux pour lesquels une prise en charge hospitalière
et spécialisée en urgence est requise,

II/ DIAGNOSTIC POSITIF:

- **Confirmer l'exanthème**
- **Caractère fébrile**
- **Signes de gravité**

❑ CONFIRMER L'EXANTHÈME

- **Les lésions élémentaires dermatologiques**

Macule –papule-vésicule-pustule- bulle

autres +++++

I-MACULE:

C'EST UNE TACHE PLATE, SANS RELIEF DE MOINS DE 1 cm

Hyperpigmentée
Hypopigmentée
Érythémateuse



Copyright © 2008 Dr Eric Ehrsam, dermatologist

2-PAPULE:

ÉLEVURE CUTANÉE CIRCONSCRITE DE LA PEAU DE MOINS D'1 CM
DE Ø



PAPULE VS. MACULE



Papule

Raised skin lesion that is less than 1 cm

Examples include: Acne, heat rash, atopic dermatitis, contact dermatitis, folliculitis, warts



Macule

Flat skin lesion that is less than 1 cm

Examples include: Vitiligo, melasma, acne marks, freckles, birthmarks, tinea versicolor

LIFEPATHDOC.COM

3-VÉSICULE:

ÉLEVURE CIRCONSCRITE DE LA PEAU DE Q INFERIEUR A 1 CM
CONTENANT UNE SÉROSITÉ CLAIRE



4-PUSTULE:

SEMBLABLE A LA VÉSICULE ET N'EN DIFFÈRE QUE PAR SON
CONTENU PURULENT



5-BULLE:

MÊME CARACTÈRES QUE LA VÉSICULE MAIS DE TAILLE SUPÉRIEURE A 1 CM DE Q



AUTRES LÉSIONS



NODULE:

MASSE SOLIDE DE SIÈGE HYPODERMIQUE (PLUS PROFONDE QUE LA PAPULE) DE Q INFERIEUR A 1 CM. (**NOUURE** SI LE Q EST SUP A 1 CM)



KYSTE:

CAVITÉ REMPLIE DE LIQUIDE SITUÉE DANS LE DERME OU L'HYPoderME



CROUTES:

EXSUDAT DESSÉCHÉ SUR LA PEAU ,SE VOIENT AU COURS DE
L'IMPÉTIGO



SQUAMES:

LAMELLES ÉPIDERMIQUES DÉTACHÉES DE LA COUCHE CORNÉE



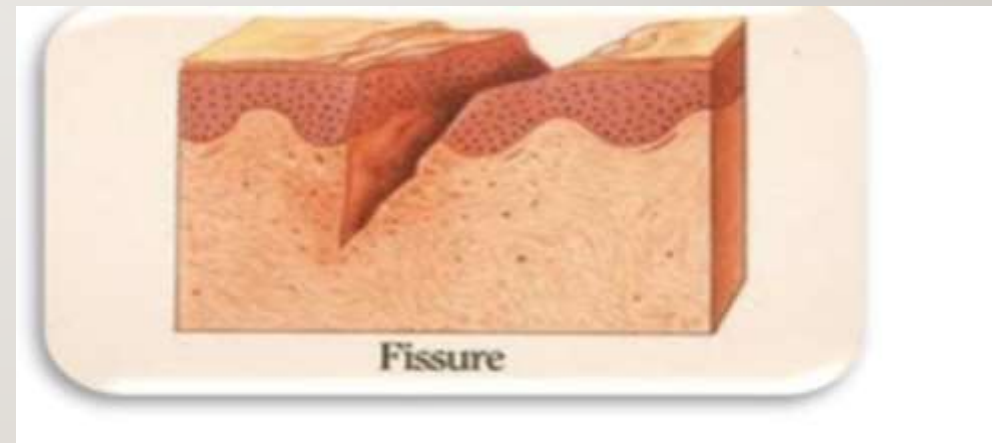
TUMEUR

FISSURE

NÉOFORMATION CUTANÉE



DÉCHIRURE DE L'ÉPIDERME



EROSION OU EXULCÉRATION:

PERTE PARTIELLE INTÉRESSANT LA COUCHE
SUPERFICIELLE DE LA PEAU (ÉPIDERME). OU
D'UNE MUQUEUSE



ULCERATION

PERTE TOTALE DE L'ÉPITHÉLIUM DE LA PEAU OU DE
LA MUQUEUSE



ÉRYTHÈME POLYMORPHE



Image cocarde arrondie bien limitée
3 cercles concentriques:

- Anneau périphérique érythémateux
- Zone moyenne œdémateuse plus claire
- Centre érythémateux surmonté d'une bulle



➡ 3 types d'**EXANTHÈMES**:

- **Exanthème maculopapuleux**
- **Exanthème vésiculopustuleux**
- **Exanthème bulleux**

IL EST IMPORTANT DE PRÉCISER:

- Importance et l'étendue de l'éruption:

- *nombre d'éléments

- ***Séparation** les uns des autres (intervalles de peau saine) ou
confluence en nappes(sans intervalles de peau saine)

- La topographie: généralisée ou localisée

- Les territoires atteints et préservés: paumes des mains ,plantes des pieds, pli de flexion ,cuir chevelu,

- Caractère prurigineux ou non

- Modes d'installation, d'extension et de régression

- Présence ou non de desquamation post-éruptive

LA FIÈVRE

- Confirmer la fièvre et l'objectiver par la prise de la température

LES SIGNES DE GRAVITÉ:

→ Recherche systématique+++
leur présence permet parfois d'orienter le dg

1-Retentissement hémodynamique

2-érythrodermie

3-Purpura extensif

4-Œdème du visage

5-Décollement cutané: (signe de Nicolsky)

6-Atteintes viscérales:

7-Hyperéosinophilie :

I -Retentissement hémodynamique

Syndrome de choc toxique :hypo TA, oligurie, marbrures cutanées...

pronostic vital est mis en jeu +++ urgence+++

Cause bactérienne :staphylococcique ou streptococcique
Toxines++

prise en charge urgente :réanimation (remplissage ,drogues vasopressives, oxygénothérapie)+
antibiothérapie+++

2-ÉRYTHRODERMIE:

- **Atteinte universelle des téguments sans espace de peau saine**
- **Toujours grave ,hospitalisation++**
- **Risques de complications systémiques**
- **Causes: infectieuse bactérienne staph**
non infectieuse :toxidermie ...

3-PURPURA EXTENSIF:

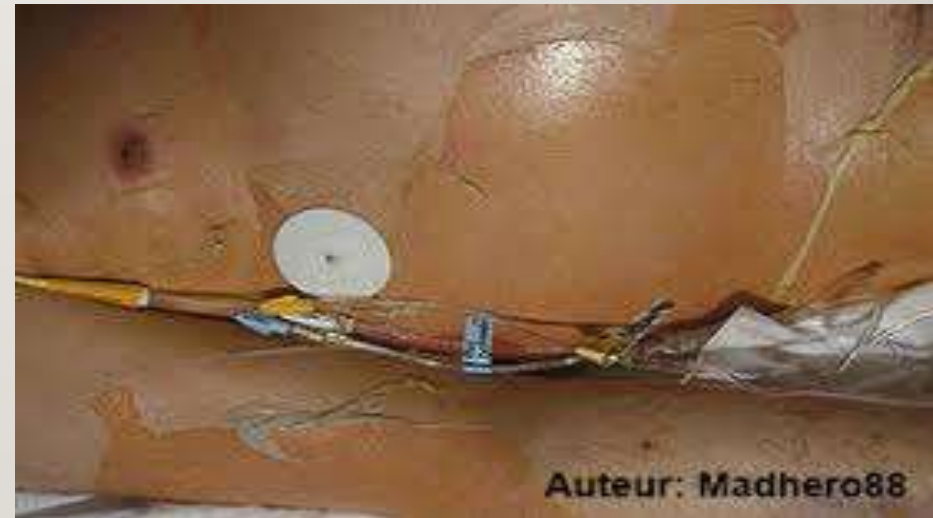
- Toujours grave **méningo+++ (purpura fulminans)**
- Autres: sepsis à **pneumocoque**, à **hémophilus**
rickettsioses (FBM)
endocardite

4-ŒDÈME DU VISAGE:

- Toujours un signe de gravité dans un contexte d'exanthème +++
- Choc anaphylactique /gravité d'une infection

5-DÉCOLLEMENT CUTANÉ:

- Signe de **Nicolsky**
- Signe de gravité de toute toxidermie: **syndrome de LYELL**



6-ATTEINTES VISCÉRALES:

- insuffisance hépatocellulaire,
- insuffisance rénale,
- syndrome méningé,
- pneumopathie interstitielle,

7-HYPERÉOSINOPHILIE :

- Taux d' **eosinophiles** supérieur à **500/mm³**
 - Signe de gravité d' une **Toxidermie**
-

DRESS syndrome: **D**rug **R**reaction with **E**osinophilia and **S**ystemic **S**ymptoms

Syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse ,survient généralement 2à3 semaines voir plus suivant l'introduction de l'agent causal :**antiépileptiques ,sulfamides ,allopurinol**

Reactivations virales HSV6-7,EBV et CMV

Maladie virale ou le médicament joue un role inducteur de reactivation

CLINIQUE :fièvre + hyperéosiniphilie+atteinte viscérales : hépatite, néphrite,pneumonie, péricardite avec risque de défaillance ++

TRT : antiviral +corticothérapie general

ne jamais reprendre le médicament++

III/ DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE:

- L' enquête épidémiologique
- Examen clinique minutieux

L' ENQUETE ÉPIDÉMIOLOGIQUE:

- **Contexte épidémiologique:**
 - ATCD de fièvres éruptives
 - ATCD vaccinaux
 - Notion de contagé familial ou scolaire
 - Voyage récent
- **Signes précédents l'éruption et leur durée**
- **Recherche systématique d'une prise médicamenteuse les jours précédents**

EXAMEN CLINIQUE MINUTIEUX: COMPLET

- **Analyse de la courbe thermique+++**

Allure ,évolution, sa survenue par rapport à la fièvre,

- **Examen des muqueuses** :rechercher un **éнанthème** :conjonctivite, pharyngite, glossite, signe du Koplik, purpura du voile du palais ,aphtose ,,,,
- Recherche d'**adénopathies**, d'**une angine**, d'une **hépatosplénomégalie**, d'**arthrite**, de **signes digestifs, respiratoires** ou **méningés..**

LES ÉTIOLOGIES:

- **Exanthèmes maculopapuleux**
- **Exanthèmes vésiculopustuleux**
- **Exanthèmes bulleux**

I/Exanthèmes maculopapuleux

❏ Origine virale

I-ROUGEOLE

□ Exanthème maculopapuleux non prurigineux avec des intervalles de peau saines , fébrile
dévolution **descendante** en 4 j.

- virus a ARN **paramyxovirus.**
- **Incubation:** 10-14 j , touche l'enfant entre 3-7 ans et l'adolescent non immunisé
- **Dg :Epidémio-clinique:**
 - *Notion de contagé ,pas de vaccination ou incomplète
 - *A l'examen: -catarrhe occulo-respiratoire.- signe de **koplik+++**
- **Evolution:**
 - favorable; apyrexie 3-4 ,j disparition de l'éruption en 1 s.
 - défavorable; encéphalite, pneumonie, surinfection (otite, pneumonie...)



ROUGEOLE

- Déclaration obligatoire+++
- **Traitement:**
 - symptomatique.
 - ATB en cas de surinfection bactérienne.
 - VIT A en cas de malnutrition (éviter les lésions oculaires et la cécité).
- Prévention: **vaccination**

2-RUBÉOLE

- Exanthème maculeux peu érythémateux avec adénopathies cervicales postérieures, arthralgies ,
- Virus à ARN togaviridae.
- incubation : 14 j en moyenne.
- Evolution: +svt favorable ,l'éruption disparaît en 3j
- les ADP 10 – 14 j après
- Traitement: symptomatique.

3-EXANTHÈME SUBIT (ROSÉOLE):

- ☐ Exanthème maculopapuleux fébrile **immunisant**, presque obligatoire chez l'enfant **entre 6mois et 3 ans**.
- Primo-infection par herpes virus humain (HHV6).
- Pas de notion de contagion ni épidémie.

Evolution:

- phase pré-éruptive: Fièvre à 39-40°C isolée bien supportée, disparaît en 3 j.
- phase éruptive: EMP ,avec prédominance sur la **nuque** et le **tronc** ne persiste que 12-24 h (peut passer inaperçu)
- leuco neutropénie est constante.
- Bon pronostic

Roséole



4-PRIMO INFECTION VIH

- ☐ Exanthème maculopapuleux
- touchant le **tronc**, la **face** et le **cou**,
- se voit dans **60%** des primo-infections symptomatiques.
- Dure en moyenne 10j.
- Autres manifestations: fièvre ,arthromyalgies,
- **Dg:** PCR:ARN VIH plasmatique /tests sérologiques 4eme génération

5-PRIMO INFECTION A VIRUS Epstein-Barr(EBV)

- ☐ éruption maculeuse parfois maculopapuleuse
- ☐ se voit dans **5 a 10 %** des cas de mononucléose infectieuse(MNI). **Adulte jeune**
- ☐ Constante après la prise **d'Amino-pénicilline.**

Signes associés : **fièvre ,asthénie ,angine, SPM**

- ☐ Diagnostic: le **syndrome mononucléosique** (c mononucléées:lymT)/ cytolyse hépatique, suggèrent le Dg confirmé par la sérologie ,

Trt: symptomatique

7- AUTRES:

- **A- d'origine virale:**

- ☐ **Entérovirus** (écho, coxsakie), adénovirus.
- ☐ **Grippe** et infection a **paramyxovirus**.
- ☐ **Mégalérythème épidémique** (5eme maladie):parvovirus B19
- ☐ **Hépatite B**
- ☐ **Arbovirus :**
 - * la dengue.
 - * chikungunya.
 - * le West-Nile

❑ Origine bactérienne

I-SCARLATINE

- **Streptocoque du groupe A** (streptococcus pyogenes)+production d'une **exotoxine**,

Exanthème maculopapuleux **sans intervalle de peau saine**, apparait au tour de la porte d'entrée

avant de se généraliser .

- dominant aux plis de flexion associer a :
- **Enanthème :glossite+++ d'évolution cyclique** ,desquamation post éruptive en lambeaux au niveau des extrémités,
- *T:39-40°C , pouls trop rapide.
- diagnostic: purement clinique.
- évolution : -guérison spontanée
- -cpc (RAA , endocardite,TSS).
- Trt : peni G , aminopenicilline ,macrolide...

Scarlatine



- **2/ Bactériémie à staphylocoques dorés, streptocoques pyogènes
+++/choc toxique**

Grave ,mise en jeu du pronostic vital +++

Atteinte multiviscérales de toxines :super Ag:TSST-I (staph)- EXOTOXINES Spe (strep)

- **PE** : cutanée, tissus mous, gynécologique (tampons,ABRT, post-partum).
- **Clinique** :sévère++ :fièvre +vmts + diarrhées+ hypoTA+ atteintes multiviscérales + CIVD

ERYTHRODERMIE suivi de **desquamation**

Érythème +œdème des mains+++/purpura pétéchiale /langue framboisée sont fréquemment observés

Traitement: réanimation +++ et antibiothérapie:

clindamycine inhibe les toxines+++

Associé à l'oxacilline, ou céfazoline staph

Associé à la pénicilline G strept

Chirurgie si nécessaire drainage ,nécréctomie

3/RICKETTSIOSES: GROUPE BOUTONNEUX

- **FBM** :fièvre boutonneuse méditerranéenne
 - Rickettsia conorii** transmise par la tique du chien **hipicephalus sanguineus**
 - Éruption cutanée MP constante
 - Dg clinique :éruption +escarre d'inoculation ++++
 - Trt :doxycycline

4/AUTRES CAUSES BACTÉRIENNES:

- tache rosées lenticulaires 10% des FT.
- Brucellose.
- Leptospirose.
- Syphilis secondaire.
- Bactériémie à méningocoque

❑ Origine parasitaire

-
- ❑ Helminthoses: phase invasive :urticaire et hyperéosinophilie
 - ❑ Trypanosomoses.
 - ❑ Toxoplasmose.

Origine médicamenteuse

Un certain nombre de **toxidermies** peut se révéler par un exanthème:

- **Bêtalactamines, sulfamides**, les **AINS**, certains **antiviraux: abacavir - névirapine**
- **Interrogatoire++: prise médicamenteuse** dans les jours précédents , voir plus jusqu'à 6 mois en cas de **DRESS syndrome** due à certains anti-arythmiques ou anti-épileptiques
- Tous les type d'éruption peuvent se voir, des le **1er j** en cas de sensibilisation antérieure ou plus tardivement (**7-10j** après l'antibiothérapie : **pénicillines+++**
- **Le prurit, inconstant, a une valeur d'orientation++++**
- Les symptômes régressent rapidement à l'arrêt du traitement sauf s'il s'agit d'un produit d'action prolongée (nevirapine, sulfadoxine, sulfadiazine...).

II/Exanthèmes vésiculo-pustuleux

ORIGINE **INFECTIEUSE+++/ VIRALE++++**

Les vésicules évoluent en pustules généralement

I-VARICELLE:

C'est la principale cause d'exanthème fébrile vésiculeux. Contagieuse +++

- VZV virus a ADN (herpesviridae).
- Incubation 10 a 21 j (moy 14j).
- **Macules** rosées (l'ensemble du corps ++ le visage et le tronc) → **papules** (très prurigineuses) → **vésicules** transparentes (24 h) → troubles → dessèchent → le centre se déprime : croutes
- Eléments d' age différents +++ et atteinte des muqueuses+++

VARICELLE:

- guérison spontanée en 10 à 14j
- cpc: - neurologique: ataxie cérébelleuse, encéphalite, polyradiculonévrite, myélite, méningite, paralysie faciale.
 - surinfections cutanées: AINS ,
 - pneumonie varicelleuse(adulte) formes graves chez l'immunodéprimé
 - autres: laryngite, purpura
 - thrombopénique, déshydratation

VARICELLE



2-SYNDROME MAINS-PIEDS-BOUCHE

- Cocksackie virus A16. Jeune enfant



3-PUSTULOSE VARIOLIFORME:

Surinfection des lésions cutanées érosives d'**eczéma** ou de **dermite atopique** par **HSV**

* eczéma herpeticum* .

- Lésions **vésiculopustuleuses** du **tronc** dans un contexte de fièvre et d'une
→ polyadénopathie

lésions érosives douloureuses et hémorragiques,

- Pronostic peut être mis en jeu : surinfections bactériennes-dissémination virale avec atteinte viscérales,

PUSTULOSE VARIOLIFORME



3-AUTRES:

- **Causes bactériennes :**

- *pustulose folliculaire:infections du follicule pileux d'origine staphylococcique.

- *Bactériémies à staph, méningo, ou gonocoque.

- **Médicamenteuse**

Exanthème bulleux

ERYTHÈME POLYMORPHE:

- Réaction d'hypersensibilité cutanéomuqueuse → lésions bulleuses
- Étiologies: le plus souvent médicamenteuse, chez l'enfant toujours infectieuse+++

causes infectieuses : plusieurs infections virales et bactériennes, les plus incriminées :
HSV et **Mycoplasma Pneumoniae**

Clinique: fièvre + malaise

éruption: image en cocarde, 3-4 éléments voir plusieurs dizaines parfois confluents,

élanthème: éléments bulleux → ulcérés et douloureux

(bouche-zones de jonctions CM : lèvres, orifices nasaux, OGE, marge anale)

Evolution: guérison spontanée : 2 à 3 semaines pour l'érythème polymorphe mineur

4 à 3 semaines pour l'érythème polymorphe majeur (signes généraux importants et atteinte muqueuse étendue,

TOXIDERMIES BULLEUSES:

Les syndromes de **LYELL** et **STEVENS-JOHNSON**:

- Affections aiguës graves
- Destruction : épiderme ,épithélium, muqueuses
- Décollements cutanés ,signes de Nikolsky positif :
supérieur à **30%** pour le syndrome de **LYELL**
inférieur à **10%** pour le syndrome de **STEVENS-JOHNSON**
- Cause :**MEDICAMENTEUSE++++** (sulfamides)



SYNDROME D'EXFOLIATION GÉNÉRALISÉE: nécrolyse épidermique par toxine exfoliante **staphylococcique**

- **Erythrodermie bulleuse** et **fébrile** +infection **staphylococcique** muqueuse ou cutanée
- Enfant avant 5 ans
- **Exfoliation** avec décollement de l'épiderme+ bulles se déchirent avec érosions épidermique étendues+ atteinte muqueuse :conjonctivite ,stomatite,,

CONCLUSION: points importants

- Importance d'une analyse sémiologique des lésions élémentaires
- Recherche de signes de gravité
- Anamnèse++
- Recherche de signes extra-dermatologique à l'examen physique+++
- Causes infectieuses nombreuses +++
- Les investigations à visée étiologique dépendent du contexte
- La prise en charge est fonction de l'étiologie.